

1. Пальпація молочних залоз

Сценарій. Ви - черговий хірург лікарні. В клініку звернулась пацієнтка 20 років.

Скарги: на збільшення в розмірах правої молочної залози, болі, набряк та почервоніння залози, лихоманку до 38,4 С, загальну слабкість.

Анамнез захворювання: 2 тижні тому були пологи природнім шляхом, народила здорову дитину, післяпологовий період протікав гладко. Пологи перші. Вигодовування грудне. Вищевказані симптоми виникли 3 дні тому.

Анамнез життя: Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Операцій та травм не було. Алергічні реакції на новокаїн. Спадковість: не обтяжена.

Об'єктивно: загальний стан середньої тяжкості, свідомість ясна. Шкіра звичайного кольору. Ріст 169 см, вага 70 кг. При пальпації грудна клітина безболісна. При порівняльній перкусії ясний легеневиий звук. При аускультатії легень везикулярне дихання.

ЧДР 16 за хв. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця ясні, ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС=Пс=90 за хв., АТ ліва рука 120/80 мм рт. ст. Живіт не здутий, при пальпації м'який, безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом Щоткіна-Блюмберга негативний. Аускультативно - перистальтика є. Ділянка попереку без патології. Нирки не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

Додатково:

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення	Референтні значення
Гемоглобін г/л	135	130-160г/л – для чоловіків 120-140г/л - для жінок
Еритроцити $10^{12}/л$	4,5	4,0-5,0 $\times 10^{12}/л$ – для чоловіків 3,9-4,7 $\times 10^{12}/л$ – для жінок
Кольоровий показник	1,1	0,85-1,15
Тромбоцити $10^9/л$	240	180-320 $\times 10^9/л$
Лейкоцити $10^9/л$	16,0	4,0-9,0 $\times 10^9/л$
- лімфоцити%	15	19-37%
- еозінофіли %	0	0,5-5,0%
- палочкоядерні нейтрофіли %	10	0-5,0%
- сегментоядерні нейтрофіли %	70	47,0-72,0%
- моноцити %	5	3,0 – 11,0 %
ШОЕ	30	1 – 10 мм/ч – для чоловіків 2 – 15 мм/ч – для жінок

Ультразвукове дослідження молочних залоз



№п/п	Дії	Текст
1.Комуникативні навички		
1.1	Привітатися.	Доброго дня.
1.2	Ви даєте свою згоду на проведення клінічного обстеження?	Так
Збір скарг та анамнезу		
2.1	Які у Вас скарги?	на збільшення в розмірах правої молочної залози, болі, набряк та почервоніння залози, лихоманку до 38,4 С, загальну слабкість.
2.2	Коли з'явилися скарги, що з Вами трапилось?	2 тижні тому були пологи природнім шляхом, народила здорову дитину, післяпологовий період протікав гладко. Пологи перші. Вигодовування грудне. Вищевказані симптоми виникли 3 дні тому.
2.3	Якими захворюваннями перехворіли? Чи є алергія? Чи були операції?	Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ- інфекцію заперечує. Хворіла ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Огляд з верифікацією виявлених патологічних змін.	Я проводжу огляд з верифікацією виявлених патологічних змін. Я оглядаю обидві молочні залози. Виявляю, що права залоза збільшена в розмірах, шкіра над нею гіперемована, блискуча, напружена. Візуально симетрія грудей порушена. Ознаки запального процесу очевидні.
3.2	Пальпація з верифікацією виявлених патологічних змін	Я проводжу пальпацію з верифікацією виявлених патологічних змін При пальпації правої молочної залози визначається щільне, болісне інфільтративне утворення, без чітких меж. Збільшені болісні пахвові лімфатичні вузли справа. Шкіра над утворенням гаряча на дотик

3.3	Перкусія з верифікацією виявлених патологічних змін	Я проводжу перкусію з верифікацією виявлених патологічних змін Я виконую перкусію грудної клітки — патологічних змін не виявляю, перкуторний звук ясний. Перкусія молочної залози неінформативна для діагностики в цьому випадку.
3.4	Аускультация з верифікацією виявлених патологічних змін	Я виконую аускультацию з верифікацією виявлених патологічних змін Аускультация легень — везикулярне дихання з обох боків, патологічних хрипів немає. Над ділянкою молочної залози патологічних судинних шумів не вислуховую
4. Діагностика		
4.1	Проаналізувати клінічний аналіз крові	Я аналізую клінічний аналіз крові Я відзначаю лейкоцитоз ($16,0 \times 10^9/\text{л}$), підвищення ШОЕ (30 мм/год), зсув лейкоцитарної формули вліво (паличкаядерні 10%), що свідчить про гострий гнійно-запальний процес. Це підтверджує підозру на мастит
4.2	УЗД	Я аналізую результати ультразвукового дослідження молочних залоз УЗД показує гіпоехогенну зону інфільтрації, неоднорідну структуру тканини, потовщення стінки, можливу початкову стадію абсцедування. Виявлено збільшення регіонарних лімфовузлів.
4.3	Встановити попередній клінічний діагноз	Лактаційний (гострий післяпологовий) мастит правої молочної залози, інфільтративна форма.
5. Визначення тактики ведення та лікування		
5.1	Медикаментозна терапія, фізіотерапія, особливості харчування	Я призначаю антибактеріальну терапію (амоксцилін/клавуланат пер ос 875/125 по 1 т 2 р в д), знеболювальні та жарознижувальні засоби (парацетамол). Годування дитини за потреби починаючи з хворої груди. Зціджування за потреби. Зручний бюзгалтер. При прогресуванні – пункція порожнини абсцесу.

6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6.1	Рекомендувати профілактичні заходи	Я рекомендую дотримання гігієни грудей, правильну техніку годування, повне спорожнення грудей, чергування сторін. Важливо не допускати застою молока. Навчаю ознакам початкового маститу, щоб уникнути ускладнень у майбутньому.
7.Інше		
7.1	Інформування пацієнта про можливі ризики хвороби	Я інформую пацієнтку про можливі ризики хвороби Я пояснюю, що при несвоєчасному лікуванні мастит може перейти у гнійний абсцес, флегмону, сепсис. Також наголошую на важливості контролю симптомів, дотримання призначеного лікування, інформую про можливу потребу в хірургічному втручанні. Спілкуюся делікатно, з емпатією та дотриманням етичних норм.

Чек-лист до практичної навички «Пальпація молочних залоз»

№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Визначити: - симетричність (симетричні, асиметричні) - форму (наявність/відсутність деформацій) - набряк залоз (локальний, дифузний) - шкірні зміни, якщо є: гіперемія, посилення судинного малюнка, симптом лимонної кірки, симптом умбілікації (втягнення шкіри над пухлиною), екзема навколо соска.	Сказати
5	Коректна пальпація (початок з потенційно здорової залози, подушечками II-IV пальців провідної руки, невеликими круговими рухами, рухаючись концентрично у напрямку соска, фіксуючи залозу вільною рукою.	Виконати

6	Визначити патологічне утворення, якщо наявне - охарактеризувати	Сказати – так/ні
7	Коректна пальпація ареоли і соска (стиснути сосок I і II пальцями)	Виконати
8	Визначити відхилення від норми (так, ні)	Сказати
9	Уточнити у пацієнтки його самопочуття	Сказати